Clínica Cirúrgica · Estações OSCE — Cirurgia Torácica

3 estações de 5 minutos · cada estação contém: impresso do candidato, impressos para entrega, instruções ao ator/avaliador, gabarito e checklist (cada parte começa em nova página)

1. **#CT-1** — Febre persistente e falta de ar após pneumonia (Derrame pleural parapneumônico complicado)
2. **#CT-2** — Facada no tórax com queda da pressão (Trauma torácico — hemotórax maciço)
3. **#CT-3** — Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro (Pneumotórax espontâneo primário)

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

CENÁRIO

Enfermaria de clínica médica. Você é o residente de cirurgia chamado para interconsulta.

PACIENTE

Antônio, 58 anos, sexo masculino, pedreiro, internado há 5 dias por pneumonia comunitária em uso de ceftriaxona + azitromicina.

QUEIXA PRINCIPAL

Mantém febre e piora da dispneia apesar do antibiótico. A radiografia mostra derrame pleural à direita, e a toracocentese diagnóstica já foi realizada.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Interprete o resultado do líquido pleural aplicando os critérios de Light.
2. Classifique o derrame e justifique.
3. Defina a conduta.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Peso
118/72 mmHg	108 bpm	26 irpm	38,6 °C	92% em ar ambiente	76 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, febril, taquipneico, corado, hidratado.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- APARELHO RESPIRATÓRIO: expansibilidade reduzida à direita; frêmito toracovocal abolido em terço inferior do hemitórax direito; macicez à percussão em base direita (até o 6º EIC na linha axilar média); murmúrio vesicular abolido em base direita
- CARDIOVASCULAR: taquicárdico, sem sopros

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Líquido pleural — aspecto	**Turvo, amarelo-citrino, sem odor fétido**	Límpido
Proteína pleural / sérica	**4,5 g/dL / 6,5 g/dL**	Relação > 0,5 = exsudato
LDH pleural / sérica	**1.200 U/L / 300 U/L**	Relação > 0,6 = exsudato; LSN sérico 250 U/L
pH pleural	**7,05**	7,60–7,64
Glicose pleural	**35 mg/dL**	≈ glicemia
Citologia	**18.000 céls/mm³, 90% neutrófilos**	—
Gram / cultura	**Gram: cocos Gram-positivos raros; cultura em andamento**	Negativo

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

Radiografia de tórax PA e perfil: opacidade homogênea em base direita, com apagamento do seio costofrênico e curva de Damoiseau; consolidação em lobo inferior direito. Ultrassonografia de tórax: derrame moderado com finos septos, sem espessamento pleural importante.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

NOTA AO AVALIADOR

Entregar ao candidato, já no início, o resultado do líquido pleural, a radiografia e a ultrassonografia. Exame físico somente se solicitado. Se o candidato perguntar sobre presença de pus franco na punção: “não, o líquido é turvo, não purulento”.

PERFIL DO PACIENTE

Antônio, 58 anos, pedreiro, tabagista 30 maços-ano, etilista social. Sem outras comorbidades.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Como está se sentindo	“Doutor, continuo com febre e cada dia tô mais cansado. Dói do lado direito quando respiro fundo.”
Pergunta ativa	“O antibiótico não tá funcionando? Vai precisar furar de novo?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

Sem informações ocultas relevantes — estação centrada na interpretação de exames.

COMPORTAMENTO DO ATOR

Paciente cansado, colaborativo, ansioso com a possibilidade de “colocar dreno”.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

Derrame pleural parapneumônico complicado (exsudato com pH < 7,2 e glicose < 60 mg/dL), em evolução para empiema (fase fibrinopurulenta — septações à ultrassonografia), à direita.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Derrame parapneumônico não complicado — sai: pH < 7,2, glicose < 60 e Gram positivo indicam complicação.
- Empiema franco — líquido purulento à punção (não presente); a conduta de drenagem é a mesma.
- Derrame neoplásico — exsudato com predomínio linfocitário; pouco provável com neutrofilia e quadro infeccioso agudo.
- Tuberculose pleural — exsudato linfocítico com ADA elevada; pouco provável aqui.

CONTEXTO CLÍNICO

Cerca de 40% das pneumonias bacterianas cursam com derrame. A persistência da febre após 48–72 h de antibiótico adequado deve levar à investigação de derrame complicado/empiema. A drenagem precoce reduz a necessidade de decorticação.

JUSTIFICATIVA

Critérios de Light (exsudato se ≥ 1): proteína pleural/sérica = 0,69 (> 0,5); LDH pleural/sérica = 4 (> 0,6); LDH pleural 1.200 > 2/3 do LSN sérico (> 167 U/L) → EXSUDATO. pH < 7,2, glicose < 60 mg/dL e Gram com bactérias = derrame parapneumônico COMPLICADO → indicação de drenagem.

ANAMNESE ESPERADA

- Tempo de antibiótico e resposta
- Persistência da febre, dor pleurítica, dispneia
- Comorbidades (etilismo, aspiração)

EXAME FÍSICO ESPERADO

Síndrome de derrame pleural: redução de expansibilidade, FTV abolido, macicez, MV abolido

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Análise do líquido pleural (bioquímica, pH, glicose, citologia, Gram e cultura)	Diferenciar transudato/exsudato e identificar derrame complicado.	Exsudato com pH 7,05 e glicose 35.
Ultrassonografia de tórax	Avaliar septações e guiar a drenagem.	Septações finas.
Tomografia de tórax com contraste (se falha da drenagem)	Avaliar loculações, espessamento pleural (sinal da pleura dividida).	—

CONDUTA ESPERADA

- Drenagem torácica fechada em selo d’água (dreno guiado por imagem; drenos de pequeno calibre 12–14 Fr são aceitáveis), no triângulo de segurança
- Manter/ajustar antibiótico com cobertura para anaeróbios (ex.: ceftriaxona + metronidazol ou amoxicilina-clavulanato/ampicilina-sulbactam), por 2–6 semanas guiado pela evolução e cultura
- Se loculações/drenagem inadequada: fibrinolítico intrapleural (alteplase + dornase alfa) ou videotoracoscopia (VATS) com desbridamento/decorticação
- Fisioterapia respiratória, analgesia, suporte nutricional
- Controle radiológico

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar ao paciente que há infecção no líquido ao redor do pulmão e que o antibiótico sozinho não resolve
- Explicar o procedimento de drenagem e obter consentimento

ERROS CRÍTICOS

- Classificar o derrame como transudato
- Não indicar drenagem torácica diante de pH < 7,2
- Trocar apenas o antibiótico sem drenar o espaço pleural
- Suspender o antibiótico após a drenagem

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-1 · Enfermaria — Clínica Médica (interconsulta cirúrgica) · nível moderado

Febre persistente e falta de ar após pneumonia

CHECKLIST — DERRAME PARAPNEUMÔNICO COMPLICADO

INTERPRETAÇÃO	Pts	Avaliação
Citou os 3 critérios de Light corretamente Light RW, Ann Intern Med 1972	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Calculou as relações (proteína 0,69; LDH 4) e concluiu EXSUDATO BTS Pleural Disease Guideline, 2023	2	☐ A ☐ P ☐ I
Identificou critérios de complicação: pH < 7,2 e/ou glicose < 60 e/ou Gram/cultura positivos BTS 2023; ACCP Consensus	2	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Indicou drenagem torácica fechada (guiada por US) BTS 2023	2	☐ A ☐ P ☐ I
Manteve antibiótico com cobertura para anaeróbios BTS 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Citou fibrinolítico intrapleural e/ou VATS se loculação/falha da drenagem MIST-2, NEJM 2011; BTS 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Comunicou o procedimento ao paciente e obteve consentimento CFM — Código de Ética Médica, 2019	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

CENÁRIO

Sala de emergência de hospital de referência em trauma. Equipe de enfermagem disponível. Paciente trazido pelo SAMU com colar cervical e prancha.

PACIENTE

Homem de aproximadamente 25 anos, vítima de ferimento por arma branca em hemitórax esquerdo há 30 minutos.

QUEIXA PRINCIPAL

Dispneia, dor torácica e sangramento pela ferida.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize o atendimento inicial segundo o ATLS, verbalizando cada etapa (os achados serão fornecidos conforme solicitação).
2. Identifique a lesão com risco imediato de morte.
3. Realize/descreva o tratamento imediato e as indicações de cirurgia.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	SpO2	Glasgow	Tax
82/50 mmHg	132 bpm	30 irpm	88% em ar ambiente	14 (O3 V5 M6)	35,9 °C

EXAME FÍSICO GERAL

Pálido, sudoreico, ansioso, extremidades frias, enchimento capilar > 3 s.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- A — VIA AÉREA: pérvia, fala frases curtas
- B — RESPIRAÇÃO: traqueia CENTRALIZADA; ferida de 3 cm no 5º espaço intercostal esquerdo, linha axilar anterior, sem ar borbulhando; expansibilidade reduzida à esquerda; MACICEZ à percussão em hemitórax esquerdo; murmúrio vesicular abolido à esquerda; jugulares COLABADAS
- C — CIRCULAÇÃO: pulsos periféricos finos; sem sangramento externo ativo importante; FAST: pericárdio sem derrame; sem líquido livre abdominal; E-FAST: derrame volumoso em hemitórax esquerdo
- D: Glasgow 14, pupilas isocóricas e fotorreagentes
- E: sem outras lesões

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Hemoglobina (gasometria)	**9,8 g/dL**	13–17 g/dL
Lactato	**5,6 mmol/L**	< 2 mmol/L
Débito inicial do dreno torácico (entregar após drenagem)	**1.700 mL de sangue**	—

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

NOTA AO AVALIADOR

Fornecer os achados à medida que o candidato verbaliza o exame (ABCDE). Se o candidato fizer punção de alívio no 2º EIC/4º-5º EIC: “sem saída de ar, sem melhora”. Após o candidato realizar/descrever a drenagem torácica, entregar o débito inicial de 1.700 mL. O candidato deve então indicar toracotomia.

PERFIL DO PACIENTE

Rapaz de 25 anos, vítima de agressão. Sem comorbidades conhecidas.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Ao ser abordado	“Tá... difícil... respirar... dói muito...”
Nome / o que aconteceu	“Paulo... me furaram... com faca...”
Alergias / medicamentos	“Não... nada...”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

Sem informações ocultas — estação de habilidade de atendimento ao trauma.

COMPORTAMENTO DO ATOR

Ansioso, taquipneico, fala palavras entrecortadas. Torna-se mais sonolento se o candidato demorar a agir.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

Hemotórax maciço à esquerda (≥ 1.500 mL à drenagem inicial) com choque hemorrágico classe III, por ferimento penetrante de tórax — indicação de toracotomia de urgência.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Pneumotórax hipertensivo — entra por choque e MV abolido; sai por MACICEZ (e não timpanismo), traqueia centralizada e jugulares colabadas.
- Tamponamento cardíaco — entra por choque em ferimento precordial; sai por FAST sem derrame pericárdico e jugulares colabadas.
- Pneumotórax aberto — sai: a ferida não aspira ar.
- Lesão abdominal associada (ferimento toracoabdominal) — FAST sem líquido livre; manter vigilância.

CONTEXTO CLÍNICO

Hemotórax maciço é o acúmulo rápido de > 1.500 mL de sangue (ou > 1/3 da volemia) no tórax, geralmente por lesão de vasos sistêmicos ou hilares em trauma penetrante. É lesão com risco imediato de morte a ser identificada e tratada no “B/C” da avaliação primária.

JUSTIFICATIVA

Choque + MV abolido + MACICEZ à percussão unilateral + jugulares colabadas = hemotórax maciço. A drenagem inicial de 1.700 mL (≥ 1.500 mL) confirma e indica toracotomia.

ANAMNESE ESPERADA

AMPLA: alergias, medicamentos, passado médico, última refeição, ambiente/mecanismo

EXAME FÍSICO ESPERADO

- ABCDE sequencial com restrição de coluna conforme protocolo
- Inspeção, palpação, percussão e ausculta do tórax
- Avaliação das jugulares e posição da traqueia
- E-FAST

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
E-FAST	Avaliação à beira-leito de hemotórax, pneumotórax, pericárdio e abdome — não atrasa a conduta.	Hemotórax volumoso esquerdo; pericárdio e abdome sem líquido.
Tipagem sanguínea, prova cruzada, gasometria, lactato, hemoglobina	Preparo para transfusão e avaliação da perfusão.	Lactato elevado, Hb em queda.
Radiografia de tórax	Somente após estabilização/procedimento — NÃO deve atrasar a drenagem no paciente instável.	—

CONDUTA ESPERADA

- O_2 suplementar em alto fluxo (máscara com reservatório 10–15 L/min)
- 2 acessos venosos periféricos calibrosos; coleta de exames e tipagem
- Ressuscitação hemostática: hemoderivados precoces (concentrado de hemácias, plasma e plaquetas — protocolo de transfusão maciça), cristaloide aquecido limitado (até 1 L)
- Ácido tranexâmico 1 g EV em 10 min nas primeiras 3 h + 1 g em 8 h
- Drenagem torácica: dreno 28–32 Fr no 5º espaço intercostal, entre as linhas axilares anterior e média (triângulo de segurança), à esquerda, conectado a selo d’água; considerar autotransfusão
- Indicação de toracotomia de urgência: drenagem inicial ≥ 1.500 mL, ou > 200 mL/h por 2–4 h, ou necessidade persistente de transfusão/instabilidade

- Acionar cirurgião torácico/centro cirúrgico
- Curativo da ferida, profilaxia antitetânica e antibiótico profilático conforme protocolo

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Liderança da equipe, comunicação em alça fechada
- Explicar brevemente ao paciente os procedimentos

ERROS CRÍTICOS

- Não seguir a sequência ABCDE (ex.: pedir radiografia antes de estabilizar)
- Confundir com pneumotórax hipertensivo e não realizar drenagem torácica
- Inserir o dreno fora do triângulo de segurança (ex.: abaixo do 6º EIC / linha hemiclavicular)
- Não indicar toracotomia diante de drenagem inicial ≥ 1.500 mL
- Ressuscitação com grandes volumes de cristaloide sem hemoderivados

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-2 · Sala de Emergência — Trauma · nível difícil

Facada no tórax com queda da pressão

CHECKLIST — HEMOTÓRAX MACIÇO (ATLS)

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA	Pts	Avaliação
Seguiu ABCDE: via aérea com restrição cervical, O_2 em alto fluxo e monitorização ATLS — 10ª edição, ACS 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I
Examinou o tórax (inspeção, percussão, ausculta), traqueia e jugulares ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Obteve 2 acessos calibrosos, coletou tipagem e solicitou E-FAST ATLS 10ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Diagnosticou hemotórax maciço com choque hemorrágico ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Diferenciou de pneumotórax hipertensivo (macicez vs timpanismo, jugulares) e tamponamento ATLS 10ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I

TRATAMENTO	Pts	Avaliação
Indicou drenagem torácica (28–32 Fr) no 5º EIC entre linhas axilares anterior e média ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Iniciou hemoderivados / protocolo de transfusão maciça e ácido tranexâmico ATLS 10ª ed.; CRASH-2, Lancet 2010	1	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou toracotomia (≥ 1.500 mL inicial ou > 200 mL/h por 2–4 h ou instabilidade) ATLS 10ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

CENÁRIO

Pronto-socorro geral, 10h da manhã.

PACIENTE

Lucas, 21 anos, sexo masculino, estudante universitário.

QUEIXA PRINCIPAL

Dor súbita no lado direito do peito e falta de ar desde que acordou, há 3 horas.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame físico dirigidos (achados fornecidos mediante solicitação) e solicite o exame diagnóstico.
2. Interprete o exame, formule o diagnóstico e classifique o tamanho.
3. Proponha a conduta e as orientações de alta.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Peso	Altura	IMC
122/76 mmHg	98 bpm	22 irpm	36,6 °C	94% em ar ambiente	62 kg	1,86 m	17,9 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, longilíneo, consciente, discretamente taquipneico, sem cianose.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- APARELHO RESPIRATÓRIO: traqueia centralizada; expansibilidade reduzida à direita; frêmito toracovocal diminuído à direita; HIPERTIMPANISMO à percussão do hemitórax direito; murmúrio vesicular diminuído à direita
- CARDIOVASCULAR: ritmo regular, bulhas normofonéticas; jugulares sem turgência

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PA (entregar se solicitada): linha de pleura visceral visível em hemitórax direito, com ausência de trama vascular periférica; distância entre a pleura visceral e a parede torácica de 3,5 cm ao nível do hilo e 5 cm do ápice à cúpula; mediastino centrado; sem derrame; pulmão esquerdo normal.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Exame físico e radiografia SOMENTE se solicitados. Se o candidato pedir tomografia ou D-dímero como primeiro exame, informar “não disponível no momento — qual exame inicial o senhor solicitaria?”.

PERFIL DO PACIENTE

Lucas, 21 anos, estudante de engenharia. Fuma 10 cigarros/dia há 4 anos e usa maconha nos fins de semana. Pratica mergulho recreativo. Sem doenças pulmonares prévias.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Acordei com uma pontada forte do lado direito do peito, e agora tô com falta de ar. Piora quando respiro fundo.”
Início	“Foi de repente, eu tava deitado, não fiz esforço nenhum.”
Episódios prévios	“Nunca tive isso antes.”
Tabagismo / drogas	“Fumo uns dez cigarros por dia. E fim de semana às vezes fumo maconha.”
Pergunta ativa — viagem	“Doutor, eu tenho uma viagem de avião marcada daqui a 5 dias e um mergulho no mês que vem. Posso ir?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Pratica mergulho autônomo (com cilindro) — só revela se perguntado sobre atividades/esportes ou na pergunta ativa
- Uso de maconha — só revela se perguntado sobre drogas

COMPORTAMENTO DO ATOR

Jovem tranquilo, um pouco assustado com a dor. Insiste em saber sobre a viagem e o mergulho.

GABARITO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

Pneumotórax espontâneo primário à direita, GRANDE (≥ 2 cm ao nível do hilo — BTS; ≥ 3 cm ápice-cúpula — ACCP), sintomático, sem instabilidade (não hipertensivo).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Pneumotórax hipertensivo — sai: estável hemodinamicamente, traqueia centrada, sem turgência jugular.
- Tromboembolismo pulmonar — dor pleurítica e dispneia, mas a radiografia confirma pneumotórax.
- Pneumotórax espontâneo secundário — sai: sem doença pulmonar de base (DPOC, fibrose cística, etc.).
- Dor musculoesquelética/pericardite — sai pelo exame e radiografia.

CONTEXTO CLÍNICO

O pneumotórax espontâneo primário ocorre tipicamente em homens jovens, altos e magros, tabagistas (inclusive de maconha), pela ruptura de blebs subpleurais apicais. Recorrência de ~30% após o primeiro episódio.

JUSTIFICATIVA

Dor pleurítica súbita e dispneia em jovem longilíneo, com hipertimpanismo e MV diminuído unilateral; radiografia mostrando linha pleural visceral sem trama periférica. Tamanho: 3,5 cm no hilo (≥ 2 cm = grande pela BTS).

ANAMNESE ESPERADA

- Caráter e início da dor
- Dispneia
- Episódios prévios
- Tabagismo e uso de maconha
- Doença pulmonar prévia
- Atividades de risco (mergulho, voo)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Avaliar sinais de instabilidade/pneumotórax hipertensivo (traqueia, jugulares, PA)
- Percussão (hipertimpanismo) e ausculta (MV diminuído)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Radiografia de tórax PA em inspiração	Exame inicial para diagnóstico e medida do tamanho.	Pneumotórax direito grande.
Tomografia de tórax	Não rotineira; útil em dúvida diagnóstica, recorrência ou planejamento cirúrgico.	Blebs apicais.

CONDUTA ESPERADA

- Paciente estável, sintomático e com pneumotórax grande: oxigênio suplementar e analgesia + evacuação do ar — aspiração por agulha/cateter (16–18 G) OU dreno de pequeno calibre (≤ 14 Fr) / dispositivo ambulatorial com válvula unidirecional (BTS 2023); se sintomas mínimos, o manejo conservador com observação é opção
- Radiografia de controle
- Indicações de cirurgia (videotoracoscopia com bulectomia + pleurodese): recorrência ipsilateral, primeiro episódio contralateral, pneumotórax bilateral, fístula aérea persistente > 5 dias, hemopneumotórax, profissões de risco (pilotos, mergulhadores)
- Orientações: cessar tabagismo (cigarro e maconha) — principal fator modificável de recorrência; NÃO viajar de avião até resolução radiológica completa (em geral aguardar 1–2 semanas após RX normal); mergulho autônomo contraindicado definitivamente, salvo após cirurgia definitiva (pleurectomia bilateral); retornar imediatamente se nova dor/dispneia

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar o que é “ar fora do pulmão”
- Responder com clareza sobre o voo e o mergulho
- Aconselhamento antitabagismo

ERROS CRÍTICOS

- Não solicitar radiografia de tórax
- Liberar o voo em 5 dias sem confirmação da resolução radiológica
- Liberar mergulho autônomo
- Indicar toracotomia de urgência ou tratar como pneumotórax hipertensivo em paciente estável
- Não orientar cessação do tabagismo

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Torácica · Estação #CT-3 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor no peito súbita e falta de ar em jovem magro

CHECKLIST — PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO PRIMÁRIO

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Pesquisou fatores de risco (tabagismo, maconha, episódio prévio, doença pulmonar) BTS Pleural Disease Guideline, 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Avaliou sinais de pneumotórax hipertensivo/instabilidade BTS 2023; ATLS 10ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou radiografia de tórax PA BTS 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Diagnosticou pneumotórax espontâneo primário e classificou como GRANDE (≥ 2 cm no hilo) BTS 2023; ACCP Delphi Consensus 2001	2	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Indicou O_2, analgesia e aspiração por agulha ou dreno de pequeno calibre BTS 2023	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou indicações de videotoracoscopia (recorrência, contralateral, bilateral, fístula > 5 dias, profissões de risco) BTS 2023; SBCT	1	☐ A ☐ P ☐ I

ORIENTAÇÕES	Pts	Avaliação
Contraindicou voo até resolução radiológica BTS Air Travel Recommendations, 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I
Contraindicou mergulho autônomo BTS 2023	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou cessação do tabagismo (cigarro e maconha) e sinais de retorno BTS 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado